Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 2ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810350

Processo nº 0000615-53.2024.8.17.2021

AUTOR(A): M. S. S. F. D. S.
REPRESENTANTE: DANIELLE AMANDA SOARES FERREIRA DE LIMA

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos, etc...

MARIA SOPHIA SOARES FERREIRA DA SILVA, menor impúbere, neste ato representada por sua genitora, Danielle Amanda Soares Ferreira da Silva, devidamente qualificada à inicial, propôs a presente *AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA* contra **HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA**, também qualificada.

Aduz a parte autora, menor impúbere de apenas 8 meses de vida, que, no dia 20 de fevereiro de 2024, aderiu ao Contrato de Assistência Médico Hospitalar oferecido pela empresa demandada, mantendo-se adimplente desde então.

Relata que, diante de sinais de cansaço e dificuldade para respirar, procurou ajuda médica, tendo sido diagnosticada com pneumonia no dia 03/04/2024. Informa que, a despeito do diagnóstico e da pouca idade, foi liberada para realizar o tratamento em domicílio, mas, não observando melhora nos sintomas, retornou ao hospital, ocasião em que lhe foi indicada internação na ala vermelha do hospital da demandada, posteriormente substituída por colocação em “sala de observação”.

Informa que estaria há mais de 24 horas na referida sala de observação, negando-se a demandada a cobrir com a solicitação médica de internação em clínica pediátrica em razão de alegado período de carência. Registra, por fim, que foi comunicada pela Ré de que esta buscaria viabilizar seu internamento no SUS.

Entende a demandante que a conduta da demandada em negar autorização para o internamento requerido, diante de seu quadro clínico, é ilegal, pois vai de encontro à própria natureza do contrato, ao CDC e à lei nº 9656/98.

Informa que o ato ilícito praticado pela requerida lhe gerou danos de ordem moral.

Diante de todo o exposto, requereu a demandante:

a) a concessão de tutela provisória de urgência para que a demandada sejam compelidas a autorizar o internamento clínico em pediatria de seu hospital, até o total restabelecimento de sua saúde, sem qualquer limitação, restrição ou exclusão dos seus direitos, sob pena de multa diária;

b) a procedência da ação, com a confirmação da liminar;

c) a condenação da demandada em indenização pelos danos morais causados à autora, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

d) a condenação da demandada nas custas processuais e honorários de sucumbência.

Juntou procuração e documentos de mérito. Pugnou pela gratuidade da justiça.

A tutela provisória de urgência foi deferida nos termos requeridos (ID 166457132). Na aludida decisão o juízo ainda deferiu a gratuidade da justiça.

Devidamente citada, a demandada apresentou resposta sob a forma de contestação (ID 168820782), no qual aduziu que não deixou de prestar o manejo clínico necessário ao diagnóstico do quadro de saúde da autora. Afirma que a demandante foi devidamente atendida no dia 04.04.2024, tendo sido acompanhada pela equipe médica para que seu quadro clínico fosse devidamente estabilizado, sendo internada na data de 06.04.2024.

Pontua que a demandante se encontrava em estado geral bom, ativo, reativo, hidratado, sem demais queixas, sendo, segundo aduz, inconteste que seu quadro clínico era de estabilidade, condição que evidencia a ausência de urgência/emergência, permitindo, assim a imposição do prazo de 180 dias o que autorizaria a sua transferência para unidade do SUS.

Prossegue aduzindo que segundo dispõe a legislação de regência haveria uma carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias, a qual não fora cumprida pela demandante. Afirma que "não há que se falar em declaração de nulidade de cláusula, uma vez que a cláusula se encontra fortemente amparada em legislação vigente, restando impugnada alegando em contrário".

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a demandada defende não ter havido ato ilícito ou conduta de má prestação do serviço que pudesse lhe imputar uma condenação a título de danos morais.

Requereu, diante do exposto, a improcedência dos pedidos autorais. Juntou procuração e documentos.

Intimada a parte para informar se pretendia produzir novas provas (ID 172570009), a demandada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 174241047).

A parte autora apresentou réplica (ID 174860714), impugnando as alegações formuladas na contestação e reiterando os termos da inicial. Na referida petição informou, ainda, seu desinteresse da produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. DECIDO.

Como não há questões processuais pendentes, passo a analisar, desde já, o mérito.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, visto que, após intimadas, as partes não requereram a produção de outras provas. Além disso, não há necessidade de dilação probatória, considerando que os documentos juntados são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Ademais, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, demonstrando seu desinteresse na produção de outras provas. Portanto, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I do CPC.

Trata-se de ação de natureza mandamental, em que se requer a determinação para que a demandada autorize a cobertura do internamento da parte autora conforme solicitado pelo seu médico assistente, e condenatória em indenização pelos danos morais causados em decorrência da negativa de cobertura do internamento clínico.

De início, importante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor se aplica à presente relação jurídica, nos termos da Súmula 608 do STJ, uma vez que não se trata de um plano de saúde administrado por entidades de autogestão. De acordo com o referido enunciado sumular: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

À luz do **microssistema consumeirista**, portanto, passo a analisar a licitude ou não da negativa da demandada em autorizar e custear o internamento clínico em pediatria motivadamente requerida pelo médico da demandante sob a alegação de não cumprimento do período de carência contratual. Noutras palavras: é legítima a recusa por parte da operadora ré em não autorizar o procedimento médico de que necessitava a autora?

Ora, se as obrigações da demandante estão devidamente quitadas e existe a necessidade da realização dos referidos procedimentos, ante a comprovada emergência, tenho que a negativa da realização dos procedimentos vai de encontro ao que dispõe o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 51, IV. Portanto, as cláusulas contratuais são passíveis de correção pela via judicial, com o reconhecimento de sua nulidade.

A doutrina de Cláudia Lima Marques[1] aponta o reconhecimento da invalidade da pactuação negocial munida com cláusulas abusivas, em muitos casos influenciando a elaboração da Lei 8.078/90, exemplificando, dentre outras situações, aquelas restritivas de obrigações em planos de saúde, como no caso.

Ademais, entendo que os argumentos apresentados pela demandada em sua peça de defesa quando confrontados com os documentos de ID's 166412550/166412551 e 168820785 não se sustentam. É que pela prescrição médica a autora teria recebido alta hospitalar no dia 03.04.2024 e no dia seguinte retornado ao hospital, oportunidade em que médico teria formalmente requerido a internação clínica.

Em que pese a demandada não trazer aos autos o laudo médico em que tenha sido prescrita a internação, nem mesmo conste aparentemente esse pedido na ficha médica da paciente, fato é que a demandada negou o atendimento ao argumento de carência contratual. Ora se houve negativa é porque antes teria havido, após a realização de diversos exames, solicitação.

Ainda no dia 06.04.2024, ao cumprir a decisão liminar, da qual havia sido intimada no dia 05.04.2024, consta na ficha da paciente que a menor, autora desta ação, estaria com dificuldade para respirar, apresentando respiração rápida e ofegante e com coração acelerado.

Diante desta constatação, extraída da própria ficha médica, como poderia a demandada afirmar que a autora, menor com apenas 08 (oito) meses de idade, com quadro de infecção respiratória estaria estável?

E mais, com fundamento esta suposta estabilidade e não obstante requerimento formal do médico, negar-se a autorizar internação ao argumento de que a autora se encontrava em período de carência.

É cediço que a fixação de carência em contratos de planos de saúde é autorizada pelo art. 12, V, da Lei nº 9.656/98, entretanto, a própria lei, em seu art. 35-C, excepciona tal regra ao estabelecer a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de urgência ou emergência, tal como da hipótese em exame.

Assim, afigura-se **indevida** a negativa de cobertura do internamento em questão, eis que violou a obrigatoriedade de cobertura de atendimento prevista no inciso I do art. 35-C da Lei 9.656/98 que preceitua que *"é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos (...) de emergência, como definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesão irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente*".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp. 46.667/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007).

Dito entendimento, hodiernamente, encontra-se consolidado na Súmula nº 597 do C. Superior Tribunal de Justiça: ***a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data de contratação.***

Em igual sentido, o entendimento consolidado por este E. Tribunal de Justiça na Súmula nº 136: ***"abusiva a negativa de internamento para cirurgia de urgência e emergência, ainda que o contrato de assistência à saúde esteja em período de carência".***

Assim, a negativa de autorização do tratamento por parte da demandada reveste-se de ilicitude, pois a operadora demandada tem obrigação de autorizar o atendimento nos casos de urgência e emergência. Não são suficientes para afastar a ilicitude as alegações de que não foi autorizada porque a parte demandante se encontrava em período de carência para realização de procedimentos médicos.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, requerido contra as rés, deve ser observado se foram preenchidos os elementos que o ensejam. São eles a conduta por parte do causador do dano, desde que haja comprovação de dolo ou culpa; o nexo de causalidade entre ela e o resultado danoso; e a ocorrência do efetivo dano, ofendendo a moral e/ou a dignidade do autor.

A ilicitude da conduta já foi demonstrada nos parágrafos anteriores. O elemento subjetivo, por sua vez, não precisa ser comprovado. Ele é presumido, pois se trata de responsabilidade objetiva, decorrente da relação de consumo entre as partes, conforme demonstrado anteriormente.

Em regra, a parte autora deve comprovar efetivamente os danos causados. Ocorre que existem casos em que a existência do dano subsiste independente de comprovação, pois os próprios fatos já representam um prejuízo moral, são os casos de dano moral "*in re ipsa*".

Os tribunais têm admitido o dano moral "*in re ipsa*" em diversos casos que não se vislumbra a necessidade de comprovar o dano, pois os próprios fatos indicam nesta direção. O TJPE enfrentando caso semelhante ao destes autos já decidiu que em casos de cobertura indevida por planos de saúde, o dano moral é presumido, ou seja, os próprios fatos geram ofensa à dignidade do autor:

> **DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO (SÚMULA 35 DO TJPE). DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.** 1. Súmula 035/TJPE: "A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral". 2. A recusa de cobertura de procedimento médico é capaz de causar ao indivíduo significativo abalo psíquico, sendo, no caso, presumido (dano moral in re ipsa) desde que seja grave o estado de saúde, e haja necessidade de tratamento urgente. 3. Fixação do valor do dano moral deve seguir os ditames da razoabilidade e

proporcionalidade. Manutenção do valor arbitrado. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - AGV: 3359360 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 22/10/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2014).

Assim, não há necessidade de se provar que houve o dano, uma vez que resta clara a ofensa à dignidade e dor moral da demandante. O nexo causal entre a conduta ilícita e o dano causado também restou claro. Se não fosse a negativa de cobertura por parte da seguradora, os danos não teriam sido produzidos.

Com base no *art. 5º, X da CF*, condeno as demandadas a pagarem uma indenização à autora por lhe ocasionar danos morais, consistentes em exacerbação da angústia sofrida com a doença, enfrentando, ao mesmo tempo, a negação ao tratamento indicado por seu médico. Quanto à fixação do *quantum* indenizatório, este deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, tais como o grau de culpa do agente, sua condição econômica e a extensão do dano suportado pelo ofendido. Ainda, tem um duplo caráter: de um lado *compensatório* em relação ao constrangimento sofrido e, de outro, *pedagógico*, a fim de desestimular o ofensor a reiterar tal prática. Permitir a recorrência desta prática seria reduzir completamente a função de uma seguradora de saúde.

Tomando por base esses parâmetros, entendo que é razoável a fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim sendo, ante os fatos e fundamentos acima expostos, e com fulcro no art. 487, I do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos da parte autora para, confirmando a tutela de urgência deferida (ID 166457132) em todos os seus termos, inclusive a multa diária para o caso de descumprimento, condenar a ré:

(i) a autorizar o internamento clínico (UTI pediátrica) da parte autora;

(ii) ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

Sobre o valor da condenação em relação aos DANOS MORAIS incidirão correção monetária pela tabela do ENCOGE a partir da PROLAÇÃO DESTA SENTENÇA (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios no valor de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da CITAÇÃO, por se tratar de responsabilidade contratual (vide, por exemplo, STJ. AgInt no REsp 1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020).

Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (conteúdo patrimonial da obrigação de fazer + valor da indenização por dano moral), com as correções de direito.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu posterior desarquivamento.

Intimem-se as partes e o Órgão Ministerial.

Cumpra-se.

Recife, datado e assinado eletronicamente.

---

[1] MARQUES, Cláudia Lima. *Contratos no código de defesa do consumidor*. 2 ed. São Paulo: RT, 1995, p. 34.

Assinado eletronicamente por: ROGERIO LINS E SILVA
13/08/2024 09:57:29
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 178575486

24081309572961900000174262592

IMPRIMIR GERAR PDF